

a7_event_structuring 测试报告

生成时间：2026-05-08 20:14:41

测试时间：2026-05-08 20:14:41

- 一、测试目的：验证工具增强对输出质量提升作用。
- 二、测试内容：同一输入下，分别运行 use_tools=True/False。
- 三、测试方法：对比输出结构与长度，核对产物路径。
- 四、测试过程：
1) 启用工具运行；2) 禁用工具运行；3) 指标对照；4) 结论归纳。

五、测试结果：

启用工具 success=True chars=1088 markers=20

禁用工具 success=True chars=954 markers=23

工具说明：tool_老人主体:tool_老人主体：从长者智能计算图提取历史参考证据

tool_近况摘要:tool_近况摘要：从长者智能计算图提取历史参考证据

tool_风险洞察:tool_风险洞察：从长者智能计算图提取历史参考证据

tool_照护服务记录:tool_照护服务记录：从长者智能计算图提取历史参考证据

tool_健康评估记录:tool_健康评估记录：从长者智能计算图提取历史参考证据

六、结论：工具可显著提升智能体输出准确性、完整性与专业性，助力机构提供更精准照护与医疗服务。

【启用工具输出摘录】

BPSD 事件报告

事件日期：2026-05-08

事件时间：10:00

事件发生场景：机构二楼活动区

事件行为类型：拒绝康复 + 社交回避

是否复合事件：否

初始风险等级：中

事件描述

2026年5月8日上午10时，失智长者陈萍忠（阿尔兹海默病性痴呆病史，心脏起搏器植入术后）在机构二楼活动区参与日常照护安排。照护员依据其个人兴趣（喜爱跳舞）及专项任务包，邀请其参加简易舞蹈康复训练。老人当即明确拒绝配合，随即转身坐于椅子上，全程保持沉默，未与照护员进行语言交流，亦未出现哭闹、攻击、躁动等过激行为。

照护员立即采取非药物干预措施，采用语言安抚并尝试以“跳舞”相关话题进行兴趣引导与情绪转移。约10分钟后，老人情绪趋于平稳，面部表情放松，但仍坚持不参与康复训练。随后，老人自行起身，在活动区内缓慢走动，行为平静，无定向障碍表现。

事件发生期间，家属在场目睹全过程，表现出明显焦虑情绪，并主动向照护员询问是否存在更适宜的干预策略。

关键字段记录

- **事件前30分钟描述**：09:30 – 10:00，老人完成晨检后独坐于活动区，言语交流极少，状态安静但疏离。
- **护理员判断原因**：对集体康复训练情境产生心理压力；同时，当值照护员为近期轮岗人员，老人对其熟悉度较低，可能加剧回避反应。
- **患者即时反应**：初始沉默静坐 → 情绪缓解后自行缓慢走动，无对抗或激越行为。
- **照护员应对方式**：语言安抚 + 兴趣话题转移（聚焦其喜爱的舞蹈主题）。
- **稳定时长**：约10分钟。
- **是否已通知护士**：是（10:20通过电话通报当班护士）。
- **是否触发升级**：否（事件可控，未达升级标准）。
- **现场图片/音频索引**：
 - 图片：IMG_20260508_1008.jpg
 - 音频：AUD_20260508_1012.m4a

备注

本次事件表现为典型的轻度行为心理症状（BPSD），以社交退缩与康复抗拒为主，符合该长者近期“非药物干预依从性低”的行为模式。虽未造成安全事件，但反映出环境适应性与照护人员熟悉度对失智长者参与意愿的重要影响。建议后续康复安排尽量由固定照护员执行，并采用更个体化、低压力的引导方式。家属沟通需加强，适时提供非药物干预原理说明以缓解焦虑。

（本报告依据照护员实时记录生成，历史健康数据仅作参考，未用于字段填充。）

【禁用工具输出摘录】

BPSD 事件报告

- **事件日期**：2026-05-08
- **事件时间**：10:00
- **事件发生场景**：机构二楼活动区
- **事件行为类型**：拒绝康复 + 社交回避
- **是否复合事件**：否
- **初始风险等级**：中

****事件描述**：**
今日上午10:00，失智老人陈萍忠（上海籍，诊断为阿尔茨海默病性痴呆，有心脏起搏器植入史）在二楼活动区参与日常活动。照护员依据其个人专项任务包，结合其既往对跳舞的兴趣，

邀请其参加简易舞蹈康复训练。老人当即明确拒绝配合，随即转身坐于椅子上，保持沉默，拒绝与照护员进行任何形式的沟通。期间未出现哭闹、喊叫、攻击或躁动等过激行为，表现为情绪性退缩。

****事件前30分钟描述**：**

09:30至10:00期间，老人完成晨检后独自坐在活动区，言语极少，与其他长者及工作人员基本无交流，状态较平日更为安静。

****护理员判断原因**：**

1. 对集体康复训练情境产生心理压力；
2. 当值照护员为近期轮岗人员，老人对其熟悉度较低，可能引发不安全感。

****照护员应对方式**：**

照护员立即停止训练邀请，采用温和语言进行安抚，并主动转换话题，围绕“跳舞”这一老人既往喜爱的主题展开轻松对话，避免施加参与压力。

****患者即时反应**：**

约10分钟后，老人情绪有所缓解，面部表情放松，但仍坚持不参与康复训练。随后自行起身，在活动区内缓慢走动，未再表现出抗拒或焦虑。

****稳定时长**：10分钟**

****是否已通知护士**：是（10:20通过电话向当班护士报告）**

****是否触发升级**：否**

****现场图片/音频索引**：**

- 图片：IMG_20260508_1008.jpg
- 音频：AUD_20260508_1012.m4a

****备注**：**

家属全程在场，目睹事件过程，表现出明显焦虑情绪，并主动询问是否有更适宜的干预策略。建议后续由责任护士与家属沟通，说明此类行为在失智症中的常见性，并共同制定个性化参与方案，如改为一对一、非结构化音乐互动，以降低老人压力感。同时建议安排熟悉照护员主导其康复活动，提升信任基础。

本报告基于照护员实时记录生成，符合BPSD行为观察规范。